

MANUAL MAESTRO Y BASE CLÍNICO-FUNCIONAL: APLICACIÓN "RUTA DE RECUPERACIÓN" (TRASTORNO POR JUEGO)

Este documento constituye la guía exhaustiva y detallada para servir como fuente principal, diseño de arquitectura de software, módulo psicoeducativo, catálogo de ejercicios clínicos y protocolo sistémico-familiar para la aplicación digital **Ruta de Recuperación**.

1. Marco Teórico, Psicopatología y Criterios Diagnósticos

El **Trastorno por Juego de Apuestas** (anteriormente denominado *juego patológico* o *ludopatía*) se clasifica en el **DSM-5-TR** (código F63.0) y en la **CIE-11** (código 6C50) como una adicción no relacionada con sustancias de pleno derecho. Este cambio nosológico fundamental establece que la patología no es un fallo moral, debilidad de carácter o una mala administración del dinero, sino una disfunción neurobiológica y conductual severa que compromete los circuitos cerebrales de recompensa, valoración del riesgo y control inhibitorio.

1.1 Mecanismos Neurobiológicos y Psicobiológicos

- **Circuito de Recompensa Dopaminérgico:** Al igual que en las adicciones químicas, la exposición continua al juego produce una hipersensibilización de las vías mesolímbicas y una desensibilización progresiva a reforzadores naturales (vida familiar, logros académicos, relaciones sociales, proyectos personales).
- **Refuerzo Intermitente de Razón Variable:** El diseño de las máquinas de azar y las plataformas de apuestas online genera una impredecibilidad adictiva. Los eventos de "casi acierto" (*near-misses*) provocan descargas de dopamina de intensidad similar o superior a la de una ganancia real, engañando al cerebro sobre su probabilidad de éxito.
- **Regulación Emocional y Función Disociativa:** En fases avanzadas, el juego opera principalmente por *refuerzo negativo* (alivio de la disforia, la culpa, el estrés financiero, la soledad o el aburrimiento), funcionando como un anestésico emocional temporal.
- **Abstracción del Dinero en Entornos Digitales:** Las interfaces modernas desmaterializan el valor monetario mediante saldos virtuales, bonos de bienvenida, créditos y giros gratis, reduciendo el freno psicológico del gasto.

1.2 Criterios Diagnósticos Oficiales (DSM-5-TR)

El diagnóstico requiere la presencia de un patrón persistente y desadaptativo de juego reflejado en al menos **4 de los siguientes 9 criterios** en un período de 12 meses, descartando que la conducta se deba a un Episodio Maníaco del Trastorno Bipolar:

Criterio Clínico	Descripción Diagnóstica	Manifestación e Impacto
1. Tolerancia	Necesidad de apostar cantidades crecientes de dinero para alcanzar el nivel de excitación o alivio deseado.	Escalada de pérdidas económicas; consumo veloz de sueldos y ahorros.
2. Abstinencia	Inquietud, irritabilidad, ansiedad severa o agitación psicomotriz cuando se intenta reducir o cesar el juego.	Brotes de cólera familiar, cefaleas, insomnio y malestar psicosomático.
3. Pérdida de Control	Esfuerzos reiterados e infructuosos por controlar, reducir o abandonar la conducta de juego.	Ruptura constante de compromisos y deterioro grave de la autoeficacia.
4. Preocupación Cognitiva	Pensamiento obsesivo centrado en el juego: revivir apuestas, planificar la siguiente sesión o idear formas de conseguir fondos.	Ausentismo laboral/académico, falta de concentración y desconexión afectiva.
5. Escape Emocional	Apostar con frecuencia cuando se experimenta malestar psicológico (culpa, ansiedad, tristeza, soledad).	Uso disociativo del juego para evadirse de la realidad cotidiana.
6. Caza de Pérdidas (Chasing)	Volver al juego tras perder dinero con la firme convicción de que se "recuperará lo perdido".	Núcleo de la ruina económica y espiral de endeudamiento descontrolado.
7. Ocultamiento y Mentiras	Engaño sistemático a familiares, terapeutas y amigos sobre el tiempo y dinero destinados al juego.	Destrucción de la confianza conyugal; vidas paralelas y aislamiento social.
8. Ruptura Relacional / Laboral	Pérdida o peligro grave de relaciones afectivas significativas, empleo, carrera o proyectos académicos.	Separaciones, divorcios, despidos disciplinarios y problemas legales.

Criterio Clínico	Descripción Diagnóstica	Manifestación e Impacto
9. Rescate Financiero (Bailout)	Dependencia económica de terceros para solventar situaciones de quiebra financiera desesperada.	Endeudamiento de familiares y perpetuación del patrón adictivo.

2. Ejemplos de Acciones y Conductas Típicas del Paciente

Para la correcta configuración de los módulos de detección, diarios de registro y alertas predictivas de la aplicación móvil, se categorizan los siguientes patrones de conducta observables:

Área Conductual	Acciones y Conductas Típicas Observables	Módulo y Sensor en la App
Patrones de Apuesta y Microtransacciones	• Sesiones de juego nocturno en soledad (01:00 AM a 05:00 AM) mediante el teléfono móvil. • Fraccionar ingresos en microtransacciones sucesivas (10€ a 50€) para evitar alertas bancarias notables. • Solicitar créditos exprés instantáneos por internet con intereses abusivos en cuestión de minutos.	Monitor de franjas horarias de riesgo nocturno, bloqueo de sitios de micropréstamos y registro de transacciones.
Manipulación Financiera y Rescate	• Inventar emergencias urgentes inexistentes (reparaciones mecánicas ficticias, multas falsas, gastos médicos urgentes). • Pedir dinero prestado a parientes lejanos o adultos mayores vulnerables (abuelos). • Empeñar electrodomésticos, joyas familiares o herramientas de trabajo.	Auditoría financiera compartida, validación familiar obligatoria de gastos y registro de pasivos.
Estrategias de Ocultamiento y Fuga	• Desviar intencionalmente los trayectos diarios para pasar cerca de salones de juego o casas de apuestas. • Borrado constante del historial web, chats de mensajería y alertas bancarias. • Permanecer tiempos prolongados	Check-in de rutas seguras, botón de registro de impulsos de fuga y pacto de transparencia digital.

Área Conductual	Acciones y Conductas Típicas Observables	Módulo y Sensor en la App
	encerrado en el baño o habitaciones con el móvil en silencio.	
Reacciones Emocionales Defensivas	• Reacciones de cólera, agresividad verbal o victimización ante cualquier indagación sobre finanzas. • Promesas grandilocuentes de abstinencia instantánea ("no volveré a jugar nunca más") para apaciguar reproches sin iniciar tratamiento real.	Herramienta de desescalada de conflictos y registro diario de reactividad afectiva.

3. Matriz de Roles Familiares y Protocolo de Apoyo Sistémico

La intervención con la familia busca erradicar la co-dependencia y reorganizar a los seres queridos como una red estructurada de coterapeutas funcionales:

Rol Familiar Asignado	Responsabilidades Operativas y Clínicas	Herramientas en la Aplicación
1. Coordinador Familiar	• Servir de interlocutor principal con el psicólogo y el psiquiatra tratante. • Gestionar el calendario integral de citas y fiscalizar la asistencia puntual. • Convocar reuniones breves de seguimiento familiar (15 min semanales) para revisar acuerdos.	Tablero de compromisos compartidos, calendario de citaciones y exportación de informes quincenales.
2. Responsable Financiero Temporal	• Custodiar las tarjetas bancarias, claves digitales y administrar temporalmente las cuentas. • Proporcionar un presupuesto semanal tasado en efectivo para gastos diarios indispensables. • Mantener actualizado el libro de registro de deudas y coordinar el plan estructurado de amortización.	Módulo de presupuesto supervisado, balance de pasivos y escáner de facturas/comprobantes de compra.
3. Acompañante	• Acompañar presencial o digitalmente en franjas vulnerables (cobro de nómina, fines	Botón directo de enlace SOS, agenda de

Rol Familiar Asignado	Responsabilidades Operativas y Clínicas	Herramientas en la Aplicación
de Riesgo	de semana). • Fomentar la realización conjunta de actividades de ocio libre de pantallas y apuestas. • Evitar el aislamiento prolongado del paciente.	actividades saludables compartidas y geolocalización preventiva.
4. Apoyo Emocional	• Brindar un espacio de escucha activa libre de juicios, amenazas y reproches retrospectivos. • Ayudar a desescalar discusiones durante episodios agudos de deseo de jugar. • Validar el esfuerzo diario, la transparencia y los hitos continuos de abstinencia.	Chat de refuerzo positivo, notas de ánimo predefinidas y registro de conversaciones asertivas.
5. Enlace Médico / Psiquiátrico	• Supervisar la toma rigurosa de fármacos prescritos (antidepresivos, naltrexona, estabilizadores). • Monitorear la higiene del sueño y registrar posibles efectos secundarios comunicándolos al médico.	Pastillero virtual con notificaciones cruzadas y registro de ritmos circadianos.

Guía de Pautas Conductuales Familiares

- **Lo que la familia SÍ debe hacer:** Establecer límites conductuales firmes y calmados; supervisar el dinero de mutuo acuerdo y con total transparencia; preguntar de forma directa y serena por la presencia del impulso de jugar; acompañar al tratamiento clínico; celebrar los logros de recuperación y la honestidad.
- **Lo que la familia NUNCA debe hacer: NUNCA pagar las deudas del jugador en secreto ni rescatarlo financieramente (evitar el bailout);** no entregar dinero en efectivo no planificado bajo excusas de emergencia; no humillar ni insultar; no discutir durante una crisis aguda de craving; no pretender sustituir la terapia especializada con vigilancia policíaca.

4. Plan de Acción Clínico Escalonado por Fases

Fase 1: Protección, Contención y Estabilización Inmediata (Semanas 1 a 4)

- **Autoexclusión Oficial y Bloqueo Digital:** Inscripción formal e inmediata en registros oficiales de autoexclusión (como el RGIAJ en España u homólogos locales) para vetar el

acceso a salas de juego y plataformas virtuales. Instalación de software bloqueador (Gamban, BetBlocker) en móviles, ordenadores y tabletas bajo contraseña del familiar financiero.

- **Intervención Financiera de Choque:** Cancelación de tarjetas de crédito y traspaso de la administración de ingresos a una cuenta supervisada. Prohibición estricta de solicitar nuevos préstamos para liquidar deudas anteriores sin un plan legal y estructurado.
- **Inventario Riguroso de Deudas:** Registro exhaustivo de todos los acreedores, montos adeudados, tasas de interés, fechas de vencimiento y orden de prioridad legal de pago.

Fase 2: Intervención Cognitivo-Conductual y Manejo del Deseo (Meses 2 a 4)

- **Control de Estímulos:** Modificación de rutas peatonales para evitar locales de juego, desactivación de notificaciones de resultados deportivos y eliminación de cuentas de redes sociales relacionadas con apuestas o trading.
- **Reestructuración Cognitiva:** Desarticulación sistemática de las distorsiones del jugador: la *ilusión de control* (creer que mediante análisis o habilidad se domina el azar) y la *falacia del jugador* (creer que tras varias pérdidas es matemáticamente obligatorio ganar).
- **Abordaje de Comorbilidades Psiquiátricas:** Tratamiento médico-psicológico coordinado de cuadros de ansiedad, depresión, TDAH o consumo concurrente de alcohol.

Fase 3: Rehabilitación Funcional y Proyecto Vital (Meses 4 a 8)

- **Reactivación del Ocio Saludable:** Programación obligatoria de actividades sustitutivas gratificantes sin implicación monetaria (deporte, senderismo, arte, voluntariado).
- **Devolución Progresiva de Autonomía:** Retorno paulatino y supervisado del manejo de pequeñas partidas de dinero personal condicionado a auditorías de transparencia quincenales.
- **Reparación Relacional:** Terapia de pareja o familiar para sanar las secuelas de la desconfianza, los secretos y el estrés postraumático vivido por el entorno.

Fase 4: Prevención de Recaídas y Mantenimiento Sostenido (Mes 8 en adelante)

- **Monitorización de Detonantes Precipitantes:** Vigilancia continua de los factores de recaída documentados empíricamente: manejo inadecuado del dinero (48,6%), estados emocionales negativos/estrés (25,7%), consumo de alcohol (14,3%), craving acumulado (5,7%) y presión social (5,7%).
- **Protocolo ante Deslices:** Diferenciación clínica entre "desliz" (apuesta puntual aislada) y "recaída" (retorno al patrón continuado). Acción inmediata: bloqueo de fondos, reporte obligatorio en la app y sesión terapéutica de aprendizaje sin autorreproches autodestructivos.

5. Catálogo de Ejercicios Terapéuticos para la

Aplicación

5.1 Ejercicio: Urge Surfing (Surfear la Ola del Impulso de Jugar)

Fundamento: Técnica de Mindfulness basada en que el deseo de jugar opera como una ola: nace, asciende hasta un pico máximo de tensión (3-7 minutos) y luego se extingue fisiológicamente si no se retroalimenta la conducta.

Guía de Ejecución en la App (Audio Guiado de 8 Minutos):

1. **Detención y Postura:** Siéntate cómodo con la espalda recta y los pies firmes sobre el suelo. Cierra los ojos.
2. **Localización Somática:** Escanea tu cuerpo e identifica dónde se manifiesta la tensión (presión en el pecho, nudo en el estómago, taquicardia, respiración rápida, manos inquietas).
3. **Aceptación sin Juicio:** No luches contra la sensación ni intentes bloquearla por la fuerza. Obsérvala como un fenómeno fisiológico pasajero.
4. **Respiración Diafragmática Consciente:** Inhala en 4 segundos inflando el abdomen y exhala lentamente en 6 segundos. Repite mentalmente: *"Esta urgencia es solo una ola corporal temporal; alcanzará su cresta y romperá hacia la calma sin que yo tenga que apostar"*.

5.2 Ejercicio: Registro Cognitivo ABC de Distorsiones

Fundamento: Terapia Cognitivo-Conductual para reestructurar pensamientos automáticos disfuncionales en tiempo real.

A (Antecedente / Gatillo)	B (Pensamiento Irracional)	C (Debate Racional)	Conducta Alternativa
Cobro de sueldo mensual + tarde libre en soledad.	<i>"Si apuesto 100€ en vivo, gano rápido y pago la tarjeta sin que nadie se entere."</i>	<i>"El juego nunca solucionó una deuda; siempre la multiplicó. Las probabilidades están en mi contra y terminaré arruinado."</i>	Transferir los fondos a la cuenta del responsable financiero y salir a caminar 30 minutos.

5.3 Ejercicio: Técnica de Anclaje Sensorial 5-4-3-2-1

Fundamento: Desactivación del sistema nervioso simpático y reconexión presente ante estados de agitación o disociación.

Instrucción en Pantalla: Identifica y nombra: **5** objetos que veas a tu alrededor, **4** cosas que puedas tocar físicamente, **3** sonidos del entorno, **2** olores perceptibles y **1** sensación corporal interna agradable.

5.4 Ejercicio: Exposición Gradual en Vivo con Prevención de Respuesta (EPR)

Fundamento: Técnica conductual de máxima eficacia contrastada empíricamente para

extinguir la reactividad ante pistas ambientales asociadas al juego.

Protocolo Clínico: Acompañado por el coterapeuta familiar, el paciente transita cerca de salones de apuestas llevando una suma de dinero fija prefijada sin realizar ninguna apuesta, practicando respiración profunda hasta que la ansiedad descienda a niveles basales.

6. Arquitectura Funcional, Métricas y Módulo de Crisis SOS

Módulo Funcional	Lógica de Negocio y Operación	Métricas e Indicadores
Tablero de Abstinencia y Progreso	Contador visual de días continuos sin juego; cálculo dinámico de dinero y tiempo ahorrados; desbloqueo de insignias de hito (1 semana, 1 mes, 90 días, 1 año).	• Días limpios acumulados. • Dinero preservado (€ / \$). • Nivel de bienestar subjetivo (1-10).
Craving Tracker y Diario Psicoafectivo	Check-in matutino y vespertino: evaluación de la intensidad del deseo (Escala 0-10), estado del ánimo, calidad del sueño e identificación de detonantes activos.	• Curva temporal de craving. • Correlación estrés-deseo. • Horas de sueño reparador.
Gestión Sistémica de Tareas Familiares	Checklist automatizado según el rol asignado (auditoría financiera, acompañamiento en riesgo, control de medicación, acuerdos de convivencia).	• % de tareas completadas por rol. • Índice de transparencia familiar. • Asistencia a sesiones clínicas.
Botón de Emergencia SOS	Acceso visible en 1 clic desde cualquier pantalla. Despliega un protocolo de 3 pasos: (1) Llamada automática al Acompañante de guardia; (2) Audio guiado inmediato de <i>Urge Surfing</i> ; (3) Conexión a líneas oficiales 24/7 (988 / Líneas de Ludopatía).	• Frecuencia de activaciones SOS. • Tiempo de contención. • Tasa de desescalada exitosa.